



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 336/RSPHS/I-KEP/DIR/VI/2026**

TENTANG

PENETAPAN TIM AD HOC RCA (*ROOT CAUSE ANALYSIS*)

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu rumah sakit dilakukan upaya-upaya salah satunya adalah mengurangi adanya insiden keselamatan pasien di rumah sakit termasuk KTD (Kejadian Tidak Diharapkan) dan kejadian sentinel;
- b. Bahwa untuk mengurangi adanya insiden keselamatan pasien (KTD/Kejadian Sentinel) diperlukan adanya analisa melalui RCA untuk mengetahui penyebab dari insiden tersebut;
- c. Bahwa untuk membuat RCA diperlukan penetapan tim *ad hoc* yang terkait dengan tema RCA yang akan dianalisa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a), (b), dan (c), perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS Prima Husada.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Elektronik)
6. Peraturan Direktur RS Prima Husada Nomor: 463/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2025 tentang Kebijakan Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
7. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
8. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 395/I-KEP/DIR/VI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
9. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA TENTANG PENETAPAN TIM
AD HOC RCA (*ROOT CAUSE ANALYSIS*)
- Kedua : Terhitung sejak tanggal 01 Juni 2026, menetapkan Tim AD HOC RCA
(*Root Cause Analysis*)
- Ketiga : Memberlakukan kebijakan Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
RS Prima Husada seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas yang tersebut pada ketetapan pertama
bertanggung jawab kepada Direktur RS Prima Husada;
- Kelima : Menginstruksikan kepada Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
RS Prima Husada untuk melaksanakan uraian tugas yang telah disampaikan
dalam lampiran keputusan ini, serta menyampaikan laporan
kegiatan secara rutin kepada Direktur;
- Keenam : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan butir
kesatu, dengan ketentuan akan diadakan revisi seperlunya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pasuruan

Pada tanggal 01 Juni 2026

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 336/RSPHS/I-KEP/DIR/VI/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM AD HOC RCA (ROOT
CAUSE ANALYSIS)

”

SUSUNAN TIM AD HOC RCA

KETUA : Dr. dr. Aslichah M.Kes. AFP. CHAE
NOTULEN : Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep.,Ns
ANGGOTA :
1. Ns. Sisca Puspita Sari, S.Kep
2. Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep
3. Wulandari
4. dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD
5. dr. Brilliant Margalin, Sp.PK., MARS
6. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG
7. Novia Ainur Pratiwi, S.KM
8. Shafira Rahmanisa, S.KM
9. Dwi Siska Hardiyanti, S.Kep.,Ns
10. Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes
11. Fina Fitriana Dwi Nur, Amd. RMIK
12. Laili Choirul Umma, S.Farm.,Apt.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 01 Juni 2026
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep. M.Kep.



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 336/RSPHS/I-KEP/DIR/VI/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM AD HOC RCA (ROOT
CAUSE ANALYSIS)**

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
TIM AD HOC RCA**

1. KETUA TIM AD HOC RCA

- Tugas:
 1. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan investigasi komprehensif/RCA mulai dari pembentukan hingga pelaporan.
 2. Mengatur jadwal pertemuan, pembagian investigasi lapangan, dan tenggat waktu pelaksanaan RCA (maksimal 45 hari untuk kejadian sentinel).
 3. Mengarahkan proses penentuan kronologis kejadian, identifikasi masalah (care management problem), analisis akar masalah, dan penyusunan rekomendasi perbaikan.
 4. Memastikan proses analisis berjalan secara objektif, non-punitive (tidak menyalahkan individu), dan berfokus pada perbaikan sistem.
 5. Mempresentasikan hasil analisis RCA dan rencana tindak lanjut kepada Direktur Rumah Sakit.
- Wewenang:
 1. Memanggil dan meminta keterangan dari unit kerja atau staf yang terkait dengan insiden keselamatan pasien yang sedang dianalisis.
 2. Menentukan metode analisa akar masalah yang paling sesuai dengan karakteristik insiden yang dihadapi (misal: 5 Whies, Diagram Ishikawa/Sirip Ikan, Change Analysis, dll).

2. NOTULEN

- Tugas:
 1. Mencatat dan mendokumentasikan seluruh jalannya rapat, diskusi, wawancara, dan hasil temuan tim investigasi secara terperinci.
 2. Mengumpulkan dan mengarsipkan berkas-berkas pendukung (saluran rekam medis, regulasi terkait, dokumentasi foto/fasilitas fisik) yang dibutuhkan selama proses analisis.
 3. Menyusun draf laporan akhir RCA bersama Ketua dan Anggota Tim untuk diserahkan kepada Direktur.
- Wewenang:
 1. Meminta kelengkapan berkas administrasi dan data pendukung kepada seluruh anggota tim demi kelancaran penyusunan dokumen RCA.

3. ANGGOTA TIM (Multidisiplin/Sesuai Kasus)

- Tugas:
 1. Melakukan investigasi lapangan secara langsung (observasi tempat kejadian, penelusuran fasilitas, dan telaah dokumen rekam medis elektronik maupun fisik).
 2. Melakukan wawancara (interview) kepada staf/petugas yang terlibat langsung maupun saksi mata kejadian dengan pendekatan yang humanis (non-blaming).
 3. Memetakan kronologis insiden dalam bentuk *Narrative Chronology*, *Timeline Map*, atau *Tabular Timeline*.
 4. Berpartisipasi aktif dalam sesi *brainstorming* untuk mengidentifikasi faktor kontributor (faktor pasien, staf, tugas, komunikasi, lingkungan kerja, organisasi, dan manajemen).
 5. Merumuskan rekomendasi tindakan perbaikan (action plan) yang bersifat *SMART* (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound*) guna mencegah berulangnya insiden yang sama.
- Wewenang:
 1. Mengakses dokumen rekam medis pasien yang mengalami insiden, SOP/Panduan Praktik Klinis terkait, serta area fisik lingkungan rumah sakit yang menjadi lokasi kejadian demi kepentingan analisis.